

総論

抗がん剤の分類と作用機序

分類・副作用の評価・病院と薬局の確認ポイントを図解で

1 薬剤の分類マップ

細胞障害性抗がん薬
DNA合成・細胞分裂を障害

アルキル化薬・白金製剤 シクロホスファミド シスプラチン オキサリプラチン

代謝拮抗薬 5-FU S-1 カペシタビン ゲムシタビン

微小管・トポ阻害薬ほか パクリタキセル イリノテカン ドキソルビシン

分子標的薬
がんの特徴的な分子を狙う

小分子薬(経口) イマチニブ オシメルチニブ レンバチニブ

抗体薬 トラスツズマブ ペバシズマブ セツキシマブ 抗体薬物複合体(ADC) T-DXd T-DM1

免疫チェックポイント
阻害薬
T細胞のブレーキを解除

抗PD-1抗体 ニボルマブ ベムプロリズマブ 抗PD-L1抗体 アテゾリズマブ デュルバルマブ

抗CTLA-4抗体 イビリムマブ

ホルモン療法
ホルモンの作用を遮断

乳がん タモキシフェン アナストロゾール レトロゾール フルベストラント

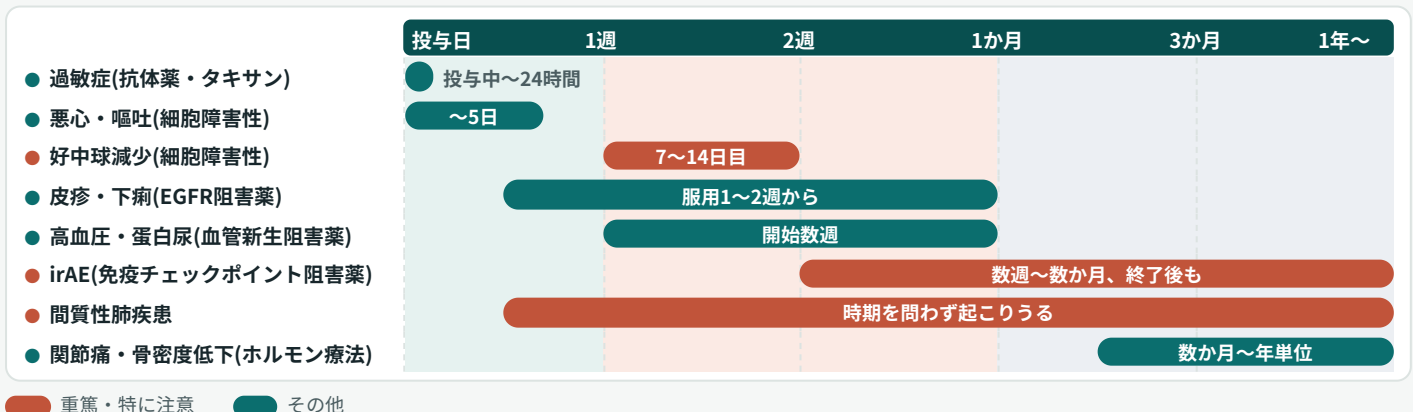
前立腺がん エンザルタミド アピラテロン リュープロレリン

☒ 経口薬(保険薬局で交付されることが多い) ☐ 注射薬

2 分類ごとの特徴と薬局での関わり

分類	標的	主な副作用	起こる時期	保険薬局での主な関わり
細胞障害性抗がん薬	分裂の速い細胞(非選択的)	骨髄抑制・悪心嘔吐・脱毛・口内炎	投与後の決まった時期(nadir等)	経口薬の服用日管理、nadir期の電話フォロー
分子標的薬	がんの特徴的な分子	標的に応じた特有の副作用(皮疹・高血圧・下痢・ILD等)	服用開始から継続的に	相互作用・服用時点の確認、スキンケア指導
免疫チェックポイント阻害薬	免疫のブレーキ(PD-1等)	irAE(皮膚・消化管・内分泌・肺など全身)	数週～数か月、終了後も	投与歴の把握、体調変化の聴取と受診勧奨
ホルモン療法	ホルモン受容体・産生	ほてり・関節痛・骨密度低下・血栓症	年単位の長期服用	アドヒアランス支援、骨・血栓の確認

3 副作用の特徴と発現時期



押さえておきたいポイント

1. 抗がん剤は4分類(細胞障害性・分子標的・ICI・ホルモン)。分類ごとに副作用の種類も時期も異なる
2. 副作用はCTCAEのGradeで評価し、Gradeに応じてセルフケア支援・処方医への連絡・受診勧奨を判断
3. 病院はレジメン監査と投与、薬局は経口薬の管理と自宅での経過確認。情報共有が安全な治療の鍵